

Grupa 1

Trimebutyna - agonista rec enkefalinowych

Który lek nie powoduje glukoneogenezy: w odpowiedziach różne przeciwcukrzycowe i odpowiedź że brak prawidłowej

Pacjent przy bólach dławicowych bierze doraźnie lek który powoduje u niego: odpowiedzi biegunka zaparcia bóle głowy i coś tam

Różnice w działaniach niepożądanych diuretyków pętlowych i tiazydowych (chyba hiperkalcemia)

Który lek jest inhibitorem angiogenezy bewacyzumab

Lek łączy się z makrofilina stosowany miejscowo - pimekrolimus

Badanie wzroku - etambutol

Wit b6 - izoniazyd

Dopasowanka: wystarczyło wiedzieć że adenozyne powoduje przejściowa asystolie

Wybierz prawidłowe: prometażyna wymioty ciężarnych

Różnica flukonazolu od ketokonazolu

Do nieopioidowych leków przeciwbólowych nie należy: buprenorfina

Błędny mechanizm: buspiron wpływ na rec AMPA

Metoprolol dożylnie co powoduje

Prawda o werapamilu że zmniejsza przebudowę serca chyba

Fałsz o metronidazolu że słabo penetruje do tkanek

Klozapina fałsz że należy do klasycznych

Loperamid-morfina-petydyna w tej kolejności rośnie lub maleje: przenikanie do OUN, efekt zapierający, przeciwbólowy

Pytanie o lek z długim pae, 2 razy dziennie- fluorochinolony

Podjęzykowo - jakie dz. niepożądane- ból głowy

Metronidazol zaznacz fałsz -słabo przenika do OUN

Co nie jest dz. niepożądanym neuroleptyków klasycznych- agranulocytoza

o skorze: że octan cyproteronu-skutek uboczny to antykoncepcja, nadciśnienie, benzoilu-odbarwia tkaniny, psoriasis, kwas azelainowy-tylko na skóre, też psoriasis, retinoidy- że wysuszenie skóry, skostnienie kostek

jakie kobiety mogą brać subst na osteoporozę wszystkie oprócz: glikokortykosteroidy fałsz, że ketolidy mają większy zakres niż makrolidy

ze ketolidy łączy z dwoma punktami i mają większe powinowactwo do czegoś

co nie jest wskazaniem leków p.histaminowych 1 generacji- szpiczasty

o mnda-tabletki, heroina-leczenie specjalistyczne uzależnienia, merycha- brak objawów uzależnienia fizycznego, psylicybina-cos że dziwne efekty

jakie działanie adrenaliny jest ważne w wstrząsie - beta1 mimetyczne, beta2 mimetycznie jakieś z alfa chyba

Grupa 2

Farmakologia 2023 baza 30.06 grupa 2

Pytanie 25 - dopasuj opis do leków przeciwcukrzycowych: metformina B12 itd, pioglitazon obniża TG itd, glimepiryd hamuje glukoneogenezę hipoglikemizujący itd, dapagliflozyna hamuje transport nerkowy glukozy itd

Pytanie 26 - dopasuj prawidłowy lek hipotensyjny do grupy: **prawidłowe lacydypina DHP antagonistą kanałów Ca**

Pytanie 34: GKS stosowane systemowo o bardzo silnym działaniu (deksametazon) mają jakie DN? **Silnie hamują podwzgórze-przysadka-nadnercza**

33 o Heroinę, MNDA, psylocybina i marihuana, jak działają MDMA- tablety, euforia Marihuana- CBD Psylocybina- nie uzależnia, derealizacja Heroina - mega uzależnia

32 antagonizm kompetycyjny dla których par leków: Nalokson i coś tam (tu chyba była para nalokson i ranitydyna), cetrydyna i coś tam

20. Który zestaw lek-odtrutka jest nieprawidłowy? A flumazenil - pochod benzodiazepiny B deferyksamina - Fe C fizostygmina - cholinolityki Tpld D nalokson - opioidy **E pilokarpina** - pestycydy fosforoorganiczne

31: który lek nieopiodowy jest stosowany w drabinie anagletycznej: klonidyna, doksepina, coś tam.. **buprenorfina (tu pytanie dotyczyło leki nieopiodowe stosowane oprócz i dlatego jest buprenorfina)**

21. Co zwiększa mac: **hipernatremia hipertermia**

22. Opis działania: **metformina, dapagliflozyna, glitazon jakiś,**

NIE! Wspólne działanie niepożądane elektrolitowe tiazydów i pętlowych hipokalcemia

Co spowoduje stosowanie tiazydów: i były różne opcje z zatrzymaniem kwasu moczowego, **hiperkalcemią**, hipokalcemią, hipokalcemia, hiperglikemia, kwasica, zasadowica, nudności, wymioty

Antybiotyk na zakażenia ośrodkowe, a doustnie na Clostridium: **wankomycyna**

Nieprawidłowe stwierdzenie o metronidazolu: odpowiedź że słabo przenika do ośrodkowego, działa na pierwotniaki i bakterie beztlenowe

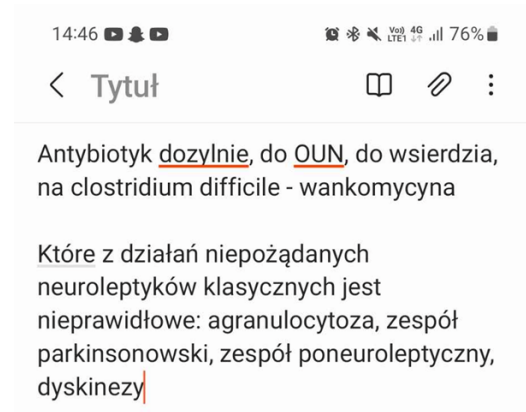
Jakie działania ma cyproteron

Z czym można stosować ibuprofen: **fluorchinolony**, metotreksat, cyklosporyna, przeciwzakrzepowe, asa

Lek hamujący angiogenezę: wymienione leki biologiczne imatynib, worinostat, aflibercept, **bewacyzumab**

Jaki lek nie powoduje zatrzymania glukoneogenezy

Leki hamujące gp2/3 czy jak to tam było



agranulocytoza

Czemu ketolidy działają lepiej od makrolidów: łączenie się z podejdnostkami rybosomu w dwóch miejscach

Karwedilol - że blokuje beta1 i alfa1

Najsilniejszy lek obniżający ciśnienie galkowe: wymienione niektóre inh. anhydrazy węglanowej, latanoprost, fakolizyna (to nie było prawidłowe bo to na zaćmę), jakiś lek na B który chyba był prawidłowy xd **BRYNZOLAMID**

Co nie jest działaniem po pobudzeniu H1: odp że ciśnienie zmniejsza, powoduje skurcz mięśni p.pokarm., działanie proarytmiczne

Co nie jest przeciwwskazaniem do stosowania blokerów H1: tu chyba było uszkodzenie szpiku, inne odp. **Psychozy**, jaskra, przerost prostaty, choroba wrzodowa

Przeciwwskazania do stosowania leków przeciwhistaminowych I generacji [edytuj | edytuj kod]

Jaskra, przerost gruczołu krokowego, nadwrażliwość na leki, uszkodzenie szpiku kostnego.

Tiamazol- nieprawidłowe wskazanie (tu była odpowiedź z niedoczynnością, bo taimazol jest w NADczynności)

Lek prokinetyczny przy wymiotach i bieguncie????? **Itopryd**

18. Wskaż fałszywe- salmeterol jest lekiem krótko działającym rozszerzającym oskrzela

17. Dopasuj mechanizm Ezetymib - najbezpieczniejszy Fibrat - obniża tg
Ewolukumab - coś z pcsk9 Statyna coś z poziomem ldl, atorwastatyna- podwyższa poziom kinazyb kreatynowej i transaminaz

29. pytanie o LZM, zbliżone do tego

92. Dopasuj 5 informacji prawidłowo charakteryzujących leki znieczulające miejscowo LZM.

☐ Lek znieczulający miejscowo (LZM)
• Zwiększenie stężenia LZM przyspiesza początek działania leku i wydłuża jego czas działania. - NIE - nie chodzi o stężenie, a ILOŚĆ <u>podanej</u> substancji • Przebieg znieczulenia przy użyciu LZM przebiega w następującej kolejności: utrata czucia głębokiego, utrata czucia ucisku i dotyku, utrata czucia bólu i temperatury. - NIE, bo odwrotna kolejność • Im lepsza rozpuszczalność LZM w tłuszczach, tym łatwiej można zmniejszyć jego toksyczność poprzez redukcję dawki. • Zwiększenie dawki całkowitej LZM przyspiesza początek działania leku i wydłuża jego czas działania. • Ich siła działania w środowisku zasadowym jest mniejsza, niż w środowisku kwaśnym. NIE - tkanki z procesem zapalnym mają niższe pH i LZM słabiej w

nich działają
• Lepsza rozpuszczalność w tłuszczach zwiększa siłę działania LZM • Blokują wywołanie i rozprzestrzenianie się potencjałów czynnościowych poprzez zapobieganie wzrostowi zależnego od potencjału przewodnictwa Na+

takie podobne tylko że zamknięte i wybrać co nie pasuje - odp że siła działania w zasadowym większa bo bardziej ZJONIZOWANE niż w kwasowym +1

Pytanie o leki przeciwhistaminowe, wskazać prawidłowe dopasowanie:

prometazyna- na wymioty w ciąży

Też o przeciwhistaminowe: nieprawidłowe dopasowanie: doksyamina, dyfenhydramina...

O działaniu leków na pokarmowy i wskazać prawidłowe: loperamid- pobudzenie perystaltyki, **trimebutyna- pobudzenie rec enkefalinowych**, simetykon- dobrze wchłaniany z przewodu pokarm, dokuzan sodowy - działanie na D2 w OUNLek hamujący wychwyt serotoniny, który powoduje zaburzenia libido, ale najmniejsze ze swojej grupy: sertralina??

Lek blokujący alfa1 i działający na (agonista) 5HT1a: **urapidyl**

Grupa 3

Falsz o kłozapie- należy do neuroleptyków typowych (klasycznych)

Stosowanie silnych systemowo dawek GKS, np. Deksametazonu powoduje- zahamowanie osi podwórze-przysadka-nadnercza

wskazanie octanu Cyproteronu Stosowany u mężczyzn w nadmiernej pobudliwości płciowej, leczenie raka prostaty. U kobiet w objawach androgenizacji (nadmierne owłosienie, trądzik, łysienie androgenozależne).

Mechanizm blokada 5h3 działa w wymiotach różnego pochodzenia - setron

Prawidłowe połączenia leki-mechanizm na cukrzyce

Przy którym leku nie trzeba badać oka- **etambutol**, ryfampicyna, izoniazyd

Lek inotropowy dodatni, w dawkach 2-20 działa na receptory beta1 i beta2 - dałam dobutamine bo dopaminy nie było

Prawidłowe o tiazydowych w długiej terapii nadciśnienia że np zmniejszają rzut serca

Lek wirusowy dermatologiczny, działa na HSV i G+ i G- i można stosować od 2 miesiąca: kwas fusydowy...

+ Coś z prawdą o IACE

Hipokaliemia, hiponatremia, hiperkalcemia jaki lek - hydrochlorotiazyd

Lek dożylnie zapalenie wsierdza itp. A doustnie clostridium difficile - wankomycyna

Działania niepożądane pozapiramidowe klasycznych neuroleptyków, które do nich nie należą? (Aktyzja, drżenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, agranulocytoza i coś jeszcze, ale to pytanie było w bazie)

Leki na kaszel - wskazać które działania niepożądane są nieprawidłowo dopasowane (kodeina, lewodropropizyna, acetylocysteina, ipratropium plus jeszcze jeden którego nie pamiętam)

Prawidłowe o DHP - było jedno że powoduje hipotonię ortostatyczną a drugie że nie powodują (nie wiem które XD)

Prawidłowe połączenie substancja uzależnienie czy jakoś tak i była heroina, LSD, Psyló coś i coś jeszcze

W przypadku stosownia jakiego leku należy suplementować wit. B6 (izoniazyd)

Błędnie połączono lek- mechanizm (flucytozyna - blok fosfofruktokinazy)

mechanizm działania tianizydyny

Pytanie o tiamazol na co nie jest i w odpowiedziach było na nieodczynnosc czyli to

o lekach przeciwpadaczkowych przyporządkować i coś było że lewetyracetam wpływa na cytochrom a drugie jakieś pojebane

Które działanie niepożądane nie jest wspólne dla tiazydów i pętlowych - hiperkalcemia

Mechanizm urapidylu

Pobudzenie rec α_2

Co jest przeciwwskazaniem do stosowania antagonistów H1

loperamid-> morfina -> pettdyna czy rośnie siła czy zmniejsza się działanie zapierające

Mechanizm lewetiracetam trzeba było zaznaczyć że bez interakcji

Wskaż nieprawidłowe połączenie lek-mechanizm działania

Amfoterycyna B

Flukonazol

Fucytozyna

Cyklopiroks

Terbinafina

Wskaż nieprawidłowe połączenie lek- charakterystyka

Tetracykliny- fototokacyjność

Fluorochinolony- nie wolno przed 18 rokiem życia

Makrolidy- na baterie atypowe

Linkozamidy- mają szerszy zakres działania niż makrolidy

Grupa 4

1. Lekiem, który działa ośrodkowo zapobiegając odruchowemu pobudzeniu lub hamowaniu układu współczulnego, działa też obwodowo na receptory alfa1 jest: Urapidyl
2. Jaki lek możesz stosować równolegle z ibuprofenem? Coś w tym stylu i odpowiedzi: metotreksat, cefalosporyna, fluorochinolon, kwas acetylosalicylowy, lek przeciwzakrzepowy
3. Czyż różni się flukonazol od ketokonazolu
4. Co NIE jest przeciwwskazaniem do stosowania H1-blokerów: a. psychozy b. Jaskra c. Przerost gruczołu krokowego d. Supresja szpiku e. Choroba wrzodowa żołądka
5. Wskaż zdanie fałszywe
 - Powinno się odstawiać antagonistów receptorów H1 przed przystąpieniem do testów skórnych
 - W silnym świądzie wykorzystuje się leki przeciwhistaminowe 1 generacji bo przenikają do mózgu i to wywołuje korzystniejsze działanie
 - Difenhydramina wykorzystywana jest jako lek przeciwwymiotny
 - Leki przeciwhistaminowe I generacji wykazują działanie na receptory H1 i na receptory cholinolinericzne
 - I coś jeszcze
6. Które leki można przyjmować niezależnie od pory dnia 1. Simwastatyna 2. Prawastatyna 3. Atorwastatyna 4. Rosuwastatyna Odpowiedz prawidłowa: 2,3,4
7. Tizanidyna mechanizm a. Agonista GABA A b. Antagonista GABA A c. Agonista GABA B d. Agonista alfa 2 e. Antagonista alfa 1
8. Co zwiększa parametr mac? I tu chyba hipernatremia i hipertermia
9. Lek prokinetyczny, zwiększający stężenie acetylocholiny, stosowany w nudnościach i wymiotach.
10. Starsza kobieta z niewydolnością serca hospitalizowana. Ustabilizowano ją. Zaczęła brać chyba werapamil i ponownie zaczęła mieć niewydolność. Jaki mechanizm był tego
11. Wskaż fałszywe zestawienie a. Klozapina - klasyczny neuroleptyk b. lewitacetam - nie ham cyp450 c. setralina powoduje dysfunkcje seksualne d. Karbamazepina - stosowana w chorobie dwubiegunowej e. Aprazolam - przeciwlękowo
12. Mechanizm działania werapamilu
13. Nieprawidłowe o znieczulających 1) ze blokowanie potencjału czynnościowego przez nasilenie przekaznictwa Na - chyba ta odp 2) wzrost lipofilności powoduje wzrost siły działania 4) wzrost lipofilności umożliwia łatwiejsze zmniejszenie toksyczności za pomocą dawki 5) wzrost dawki- szybszy początek działania i dłuższe działanie
14. Wskaż nieprawidłowe: Fenoterol należy do LABA (nie bo on SABA)
15. Prawidłowe zestawienie: Prometazyna - wymioty ciężarnych
16. Gościu ma ChNS, bierze lek na bóle dławicowe, jakie DN może jeszcze powodować (bóle głowy dałam ale czy dobrze nie wiem xD)
17. 1. Nadtlenek benzoilu - barwi ubrania, Kwas azelainowy - miejscowo w trądziku różowatym, na przebarwienia, Izotioipryna - powoduje suchość skóry i śluzówek, podrażnienia, sprzyja eradykacji P. Acnes 2. Ewolokumab - przeciwciało na PCSK9 Ezetynib - może być u dzieci stosowany Fenofibrat - obniża TG bardziej niż LDL, Atorwastatyna - może podnosić kinazę kreatynową

18. Lek na atypowe i stosowanie 2 razy w tyg i tendopatie - fluorochinolony (kombinacja innych)

Grupa 5

1. Lek wskazanie była prometazyna ondasteron lajtuloza metoklopramid i coś
2. Karbidopa i benserazyd na jaki enzym wpływają
3. Fałszywe koksyby
 1. Selektywne do cox2
 2. Powodują owrzodzenia
 3. Łączy się z asa
 4. Powodują skurcz oskrzeli
4. Przeciwlękowy, najmniej działanie na funkcje seksualne
 1. Lit
 2. Buspiron
 3. Karbamazepina
 4. Sertralina
5. Które wykazują antagonizm kompetycyjny
 1. Suksametonium i klonidyna
 2. Rupaadyna i nalokson
 3. cetyryzyna i atropina
 4. fentanyl i zufenopril
 5. Omeprazol i flutikazon
6. Kiedy suplementować witaminę B6- Terapia izoniazydem
7. Starsza pani ma ChNS ale ma zgagę co zubożniające może jej tu powodac
 1. Że bierze coś z Ca przez co hiperkalcemia
 2. Bierze coś z Al i jego kumulacja i retencja wody
 3. Bierze coś z Al i Mg
 4. NaHco3
8. Nebiwołol prawda
 1. Podjęzykowe
 2. Dodatkowo rozszerza naczynia

Dopasowywanka o metoprololu werapamilu adenozyne i siarczanów magnezu

Pytanie z bazy o oseltamiwirze, ze najszerszy zakres na grypę, trzeba było zaznaczyć ze inhibitor neuramidazy

Różnica IACE I BRA:

1. Hipotonia
2. Obrzęk naczynioruchowy
3. Aldosteron

4. I chyba hiperkaliemia

Co można z ibuprofenem

1. fluorochinolony

2. metotreksat

3. cefalosporyna

4. przeciwzakrzepowe

5. asa

Loperamid, morfina, petydyna uszeregowane:

1. Rosnąco przeciwkaszlowe

2. Rosnąco przenikające ośrodek

3. Malejąco zapierające

4. Chyba przeciwbolowe

Pytanie o fałsz

Że kateolidy mają mniejszy zakres niż makrolidy

Pytanie o fałsz o to LZM

Jedna odp o środowisku zasadowym Że wtedy mniej zjonizowane i lepiej działa

Coś było o metronidazolu

Przenika lub nie przenika do OUN

Metaliczny smak

Słabo do tkanek penetruje coś takiego

Mechanizm lewetiracetamu podany , i że dlaczego jest stosowany (Lek wspomagający w padaczce który zmienia prądy czy coś)

Trzeba było zaznaczyć że nie ma interakcji z innymi lekami i dlatego jest najfajniejszy

Jakie są działania podobne sympatykomimetyki, antag α_2 i adrenolityki

Rozszerza naczynia ?

Wzrost resorpcji Na i H_2O

Wpływ na serce że chyba mniej bije

Adenozyna na co działa - otwiera kanały potasowe, blokuje kanały wapniowe

zmniejsza szybkość przewodzenia w węzłach, obniża ciśnienie tętnicze (rozszerzenie naczyń), INOTROPOWO UJEMNIE

Najczęstsze działania niepożądane leku na niedokrwienie serca

1. Ból głowy (chyba prawidłowe)

2. Zaparcia

Fałsz o jakieś na astmę

1. Fenoterol (laba) dajemy w ataku (i to trzeba było zaznaczyć bo Saba)

Trzeba doczytać te krążenia obwodowe / mózgowe

Bo pytania z odpowiedziami w których była escyna, nicergolina, pentoksyfilina

Było coś w stylu o drabinie analgetycznej nieopiodowej i co NIE jest w tym stosowane
Odpowiedzi to m.in. **buprenorfina**

Było jeszcze o mechanizm działania tinazydyny czy coś takiego i były odp 3 z GABA

Grupa 6

1 działanie tyzanidyny

2 działanie adenozyyny

3. Mdma heroína psylocybina i marihuana leczenie zależności i efekty odstawienne

4. Efekt działania adrenaliny we wstrząsie anafilaktycznym

- Pobudzenie α_2 - rozrzedzenie oskrzeli
- Pobudzenie B_2 - rozszerzenie oskrzeli
- Pobudzenie β_1 - inotropowo dodatnio

5. Które z działań nie są wspólne dla tiazydowych i pętlowych

- **Hipokalcemia**
- Hipokaliemia
- Hiperurykemia

6. Agonista B_1 i B_2 , w dawce 2-20 jakieś działanie

- dobutamina

7. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące bromokryptyny

1. Stosowany w akromegalii
2. **Antagonista D_2**
3. W leczeniu gruczolaków przysadki mózgowej
4. Obniża stężenie prolaktyny w hiperprolaktynemii
5. W leczeniu hipogonadyzmu u mężczyzn zależnym od prolaktyny

8. Jakie są wspólne działania uboczne dla diuretyków pętlowych i tiazydowych

9. Jaki jest mechanizm działania diuretyków tiazydowych (jak obniżają ciśnienie)-
zmniejszenie objętości wyrzutowej serca, zmniejszenie oporów naczyniowych, nasilenie syntezy NO w śródbłonku

10. Efekt pobudzenia receptora H₁

Działanie poprzez rec. H₁

- **szybkie, lecz krótkotrwałe rozszerzenie naczyń krwionośnych -
↑ uwalniania śródbłonkowego NO**
- **obniżenie ciśnienia tętniczego krwi**
- **zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych ->
przechodzenie białek i płynu osocza do przestrzeni
zwnętrzkomórkowej -> obrzęk**
- **zahamowanie przewodnictwa w węźle przedsionkowo-
komorowym**
- **skurcz mięśni gładkich oskrzeli -> duszność**
- **kurcząco na mięśniówkę gładką żołądka i jelit**
- **synteza prostaglandyn**
- **świąd i zaczerwienienie (w naskórku)**
- **ból (w skórze właściwej)**
- **pobudzenie aferentnych włókien nerwu X w drogach
oddechowych**

11. Co zastosować w przypadku guza prolaktynowego czy coś takiego. Że tam pacjent się nie zgadza na operację itp. **bromokryptynę?**

12. Lek x wpływa na uwalnianie ach z szczeliny presynaptycznej i jest często podawany z innymi lekami w celu ich.

Zwiększenia penetracji do OUN

Zmniejszenia rozpadania itp.

13. Pseudojednokrotne z opioidami

Oksykodon ból trzewny

tramadol do SSRI interakcje

14. Pseudojednokrotne z histaminowymi

15. Difenhydramina wskazać fałszywe

16. Lek stosowany w dermatologii, przeciwwirusowo na HSV, przeciwbakteryjnie na gram + i -, można u dzieci od 2 miesiąca / roku? Życia

A. Sulfatiazol srebra

17. Loperamid-morfina-pentazocyna (tego 3 nie jestem pewna) w jakiej kolejności są ustawione:

A. zwiększonego przechodzenia przez OUN

B. Zwiększonego działania przeciwkaszlowego

C. Zmniejszonego działania przeciwbólowego

18. Które antybiotyki powodują tendinopatie u osób starszych

1. Fluorochinolony

19. Porównanie makrolidów i ketolidów (zakres, że ketolidy mają szerszy zakres bo łączą się z dwiema domenami i mają mniejsze powinowactwo do pompy

20. Czym leczymy C.difficile

21. Wymienione m.in wrzody, uszkodzenie szpiku, psychoza i Które działanie nie może być przy stosowaniu przeciwhistaminowych H1

22. Mechanizm działania jakiegoś przeciwgrzybiczego, ale nie pamiętałam którego

22. Mechanizm działania leku o najszerszym zakresie na grypę

23. Które z działań są wspólne dla sympatykolytyków, betablokerów chyba i agonistów presynaptycznych alfa

24. Kłozapina -> fałsz, że należy do klasycznych neuroleptyków

25. Które zestaw z odtrutką jest fałszywy

1. Pilokarpina - zw. Fosforoorganiczne

26. Co powoduje podwyższenie tego współczynnika pęcherzykowego MAC (oprócz tego aminy katecholowe, reszta obniża)

1. Hipernatremia, hipertermia

2. Alkohol hipertermia

3. Jakies leki/ klonidyna może

4. Zwiększenie uwalniania amin katecholowych, alkohol

27. Antybiotyki powodujące tendopatię - fluorochinolony

28. Przeciwwirusowy na HSV, gram + i - -

29. Efekty pobudzenie receptorów H1 (jest wyżej)

30. mechanizmy do poszczególnych przeciwgrzybiczych - amfoterycyna, terbinafina itd i zaznaczyć który mechanizm jest fałszywy (napisze jakie są poprawne)

Amfoterycyna zwiększa przepuszczalność błony, wiąże się z ergosterolami błony -> powstawanie porów

Flucytozyna- przemiana do 5-fluorouracylu i hamowanie aktywności syntetazy tymidylanu, zaburzenie syntezy DNA

Azole- hamowanie demetylasy lanosterolu-> hamowanie biosyntezy ergosterolu

Amorolfina- hamuje aktywność epoksydazy skwalenowej -> niedobór ergosterolu

Terbinafina- to samo co Amorolfina

31. przeciwwirusowy najczęściej stosowany na grypę (oseltamiwir) i jaki ma mechanizm - **inhibitor neuraminidazy**

32. chyba leki na gruźlicę i w którym trzeba kontrolować wzrok? - **ETAMBUTOL**

33. przewaga ketolidów nad makrolidami - że łączą się za pomocą 2 domen

34. inne pytanie - wybrać fałszywe, że ketolidy mają węższy zakres niż makrolidy

35. Dopasować lek do opisu

1. Jakaś statyna

2. Fibrat

3. Ewolokumab

4. Ezetynib

A. może podwyższać transferazy

B. Bezpieczny dla kobiet w ciąży

C. Silnie obniża TG

D. Hamowanie rozkładu zależnego od PCSK9 wątrobowego receptora dla LDL

Odp. 1A, 2C, 3D, 4B

36. Które statyny można zażywać bez względu na porę dnia **Prawastatyna Rosuwastatyna Atorwastatyna** (PRA masz PRAwo brać je o każdej porze dnia)

37. Co jest NIE JEST przeciwwskazaniem do stosowania blokerów H1? Do wyboru: jaskra, przerost stercza, **psychozy**, uszkodzenie szpiku

38. Który lek nie powoduje spadku glukoneogenezy? Metformina- hamuje glukoneogenezę, akarboza- , pioglitazon, gli...coś tam, żaden z wymienionych

39. fałszywe - że klozapina należy do neuroleptyków klasycznych

40. loperamid - morfina - petydyna - są uszeregowane zgodnie z powinowactwem do OUN?

41. Lewodopa jest stosowana z karbidopą i jest to inhibitor: **dekarboksylazy** / aromatazy / acetylocholinoesterazy / jakieś inne

42. oksykodon, fentanyl, pentazocyna i coś - dopasować mechanizmy do każdego

43. fałszywe, że salmeterol należy do SABA

44. fałszywe, że fenoterol należy do LABA

45. o teofilinie - że ma niski zakres terapeutyczny, nie można jako I rzutu, że w małych dawkach jest przeciwzapalne (to było chyba dobre)

46. który z GKS jest najsilniejszy? - deksametazon

47. przy stosowaniu ibuprofenu z którym z leków nie ma działań niepożądanych - był ASA, MTX, przeciwzakrzepowe, cyklosporyna, fluorochinolony
48. które z leków są stosowane przy zwalczaniu bólu ale są nieopiodowe - wykluczyć chyba buprenorfinę (bo ona była jedynym opiodem tam)
49. które z działań farmakologicznych NIE powodują NLPZ - coś z hipotonią ortostatyczną/spadkiem ciśnienia
50. wybrać które prawidłowe i dużo mechanizmów do koksylów, oksygenów, ASA, na które COX preferencyjne itd
51. fałszywe o tym, że morfina na kaszel i ma działanie obwodowe (bo ośrodkowe)
52. fałszywe zastosowanie - dekstrometorfan na kaszel przy astmie
53. fałszywe, że mesna jest stosowana tylko miejscowo
54. jaki mechanizm ma werapamil - blokowanie kanałów Ca coś tam typu L
55. lek prokinetyczny i jakiś dłuższy opis – itopryd
56. przypasować opisy do leków - metformina, pioglitazon, flozyny itd (przy których zwiększenie HDL, LDL, o wit B12, opóźnianie wchłaniania glukozy itd)
57. przypasować do opisów - Mg i te leki antyarytmiczne (klasyfikacje)
58. różnica między IACE i sartanami
59. o dobutaminie - było że dawka 2-20ug i receptory B1, B2
60. jakiś człowiek stosował lek i miał hiperkaliemię, hipokalcemię itd - lekiem tym był hydrochlorotiazyd
61. DN dla pętlowych - hipokaliemia, hiperurykemia, hiponatremia, ototoksyczność, wzrost frakcji lipidowej
62. diuretyki tiazydowe działają na serce poprzez spadek obciążenia wstępnego
63. lek poprawiający mikrokążenie - dobesylan?
64. wybrać prawdziwe o mechanizmie nebiwololu
65. wskazania dla octanu cyproteronu i wybrać jedno fałszywe
66. jaki lek może specyficznie zablokować angiogenezę? **bewacyzumab**
67. wybrać lek z dobrym mechanizmem - imatynib - inhibitor kinaz tyrozynowych
68. które działają na GP IIIa/IIb - abciksamab, eptifibatyd, tirofiban
69. że IPP blokują pompę nieodwracalnie
70. o azatioprynie - działania niepożądane charakterystyka i wybrać dobre albo złe idk

71. przypasowanie dobrego mechanizmu - setrony, na h1 itd

72. o środkach przeczyszczających - dokuzan, laktuloza itd - mechanizmy!

73. izotretynoina, nadtlenek benzoilu, octan i dopasować mechanizmy

74. zastosowanie adrenaliny we wstrząsie i dzięki jakim właściwościom ją stosujemy - skurcz naczyń, poprawa przepływu, dodatnie tropizmy

75. lek na skórę, inhibitor kalcyneuryny - pimekrolimus

76. Dopasowywanka z opioidami:

leki:

- tramadol
- buprenorfina
- morfina
- fentanyl
- oksykodon

opcje:

- ,
- wskazany w bólu trzewnym - oksykodon
- agonista rec mi (MOR) - morfina, fentanyl
- nefrotoksyczne metabolity
- nie łączyć z lekami wpływającymi na serotonine bodajże - tramadol

77. O inhibitorach konwertazy angiotensyny - że zmniejszają obciążenia i trzeba monitorować kreatyninę

78. Porównanie flukonazolu i ketokonazolu - że flukonazol ma lepszą penetrację do OUN

79. Prawdziwe że prometazyna - na wymioty w ciąży

80. Które statyny można o obojętnej porze - wszystkie oprócz simwastatyny

81. Psylocybina, marihuana, MDMA, HEROINA dopasowywanie → w formie tabletek, uzależnienie psychiczne i fizyczne, uzależnienie tylko psychiczne + senność + sichość w ustach; uzależnienie psychiczne + halucynacje

marihuana- uzależnienie tylko psychiczne, suchość w ustach

MDMA- tabletki

psylocybina- tylko psychiczne i halucyny

heroina- psych i fiz

82. Leki znieczulające miejscowo LZM (dobrze rozpuszczają się w tłuszczach, zwiększenie początkowej dawki pozwoli szybciej zadziałać i silniej, przez to że rozpuszczają się w tłuszczach

83. o blokerach kanałów Ca^{2+} typu L: mogą być stosowane w stabilnej dusznicy bolesnej, gdy nie można beta blokerów

84.1. izotretynoina - D

2. kwas azelainowy - A

3. octan cyproteron - C

4. nadtlenek benzoilu - B

(a. na trądzik, też na różowaty, niweluje przebarwienia, tylko miejscowo - kwas azelainowy

b. barwi ubrania - nadtlenek benzoilu

c. działaniem ubocznym jest antykoncepcja,

d. ? coś do retinoidów chyba coś że keratolityczny)

85. DN NLPZ